

一、疾病理解與病理機轉

心絞痛是因為供應心臟血液的冠狀動脈血管變窄或阻塞,導致心臟肌肉缺氧所引起的胸痛。就像水管用久了會生鏽堵塞一樣,血管也會因為膽固醇堆積而變窄。當您運動、情緒激動或吃太飽時,心臟需要更多血液,但狹窄的血管無法供應足夠血液,就會出現胸悶、壓迫感的症狀。穩定型心絞痛在休息或服用舌下含片後會改善,但不穩定型心絞痛發作更頻繁、更嚴重,可能是心肌梗塞的前兆,需要特別注意。

二、藥物知識與服藥遵從

1. 舌下含片(硝化甘油)應隨身攜帶,胸痛發作時立即含在舌下,5分鐘內未緩解可再含一片。
2. 抗血小板藥物如阿斯匹靈、保栓通需每天定時服用,預防血栓形成。
3. 降血脂藥物需按醫囑長期服用,不可自行停藥或調整劑量。
4. 乙型阻斷劑和鈣離子阻斷劑可減少心臟負擔,需定期監測血壓和心跳。
5. 若服用止痛藥出現便秘副作用,應多喝水、吃高纖食物並適度活動。

三、警訊辨識與處置行為

1. 胸痛持續超過5分鐘或舌下含片無法緩解時,應立即就醫。
2. 出現呼吸困難、冒冷汗、頭暈、噁心等症狀,可能是心肌梗塞徵兆。
3. 解黑便或血便、嘔吐咖啡色物質,表示可能有腸胃道出血。
4. 突然劇烈腹痛或一日多次血便,需緊急返院檢查。
5. 服用抗凝血藥物期間出現異常出血或瘀青,應告知醫護人員。

四、飲食與活動建議

1. 採低鹽、低脂飲食,每天至少吃5份蔬菜水果,避免油炸和高脂肪食物。
2. 減少攝取咖啡因、酒精、辛辣和過甜食物,以免刺激胃酸逆流。
3. 餐後1~2小時內避免平躺,睡覺時可將頭部抬高15~25公分。
4. 每週至少運動3次,每次30分鐘以上,選擇適合自己的溫和運動。
5. 戒菸並控制體重,避免穿過緊的衣服影響血液循環。

五、出院追蹤與門診照護導引

1. 按時回心臟科門診追蹤,定期檢查血壓、血脂和心電圖。
2. 若接受心導管或支架手術,需依照醫囑定期回診檢查血管狀況。
3. 合併胃食道逆流者應定期腸胃科追蹤,必要時接受內視鏡檢查。
4. 記錄每日症狀變化、用藥情形和排便狀況,就診時提供醫師參考。
5. 出現任何緊急症狀時,可撥打醫院諮詢電話(02)2737-2181分機8821尋求協助。

六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

■ 冠狀動脈疾病(ICD-10: I25119)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 隨身攜帶舌下硝酸甘油,胸痛發作時立即含服;若5分鐘未緩解可再含一片,仍無效需緊急就醫。
- 按時服用抗血小板藥物(如阿斯匹靈、Clopidogrel),不可自行停藥。
- 控制高血壓、高血脂、糖尿病等危險因子;採低鹽低脂飲食,每週規律有氧運動3次以上。

■ 高血脂症(ICD-10: E785)

- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

■ 逆流性食道炎(ICD-10: K219)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 飯後不立即平躺,睡前2小時避免進食;抬高床頭約15公分可減少夜間逆流。
- 避免油膩、辛辣、巧克力、咖啡、酒精等刺激性食物。
- 按醫師指示服用制酸劑或質子幫浦抑制劑,即使症狀消失也需依醫囑完成療程。

七、參考衛教手冊

1. 心絞痛
2. 上腸胃道出血
3. 逆流性食道炎護理指導
4. 高血脂症護理指導
5. 疼痛
6. 冠狀動脈粥樣硬化心臟病(冠心病)
7. 便秘

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31